

Luxación de caderas y dolor en la atrofia muscular espinal tipo III.

1. Caso de Referencia

Descripción Breve: Paciente de 17 años con diagnóstico de Atrofia Muscular Espinal tipo III desde los 18 meses. Logró caminar hasta los 6 años, luego pasó a usar silla de ruedas. Presenta antecedentes de fracturas y cirugía (tenotomía de Aquiles). Con la progresión de la enfermedad desarrolla escoliosis y luxación de cadera, asociada a dolor. Paciente de 12 años con Atrofia Muscular Espinal tipo III diagnosticada a los 30 meses. Camino hasta los 10 años con ayuda de ortesis. Posteriormente desarrolla escoliosis progresiva y subluxación de cadera, también asociada a dolor.

Relevancia del caso: Estos casos son importantes porque muestran como la Artrosis Muscular Espinal tipo III afecta progresivamente la movilidad, generando complicaciones musculoesqueléticas directamente en la funcionalidad y calidad de vida del paciente.

2. Perfil Funcional

- **Habilidades conservadas**

Funciones cognitivas normales, uso de miembros superiores relativamente preservados y capacidad de comunicación e interacción social.

- **Limitaciones principales**

Debilidad muscular progresiva (especialmente en miembros inferiores) también como la pérdida de la marcha, dependencia de silla de ruedas adicionalmente del dolor asociado a luxación de cadera y Escoliosis que afecta postura y respiración.

- **Escalas clínicas útiles**

Barthel o Fim para ADL, Manual Muscle Testing (MMT), Timed Up and Go (TUG), escalas de dolor (EVA/VAS) y marcadores de recambio óseo (ALP/CTX) para seguimiento terapéutico.

3. Mapa de actividades críticas

- **Vida diaria**

1. Vestirse: Sufrir una dependencia parcial debido a la debilidad en miembros inferiores, limitación de movilidad por dolor en cadera y problemas de equilibrio en sedestación.
2. Higiene Personal: Es dependiente por sufrir transferencias difíciles de silla a baño, riesgo de caídas y dolor al movilizar la cadera luxada.

3. Movilidad en el hogar: Dependiente(uso de silla de ruedas), presenta dificultades como barreras arquitectónicas, dolor al realizar cambios de posición al igual que aislamiento dentro del hogar.

- **Actividades educativas**

1. Asistencia al colegio: Requiere apoyo, acceso mediante rampas, transporte, fatiga durante la jornada escolar lo cual conlleva a un impacto ausente o dificultad para mantener rendimiento académico.
2. Uso de herramientas: Parcialmente independiente, logra una fatiga muscular, posturas prolongadas incómodas lo cual impacta en la disminución de productividad, necesidad de adaptaciones ergonómicas.
3. Interacción social: Es independiente cognitivamente hablando, sufre dificultades como las limitaciones físicas para participar en actividades lo cual causa un impacto en el aislamiento social y posible afección emocional.

- **Rehabilitación**

1. Fisioterapia motora: Es dependiente debido a las dificultades como el dolor durante movilizaciones, la fatiga rápida lo cual genera un impacto en la baja adherencia si el dolor no se controla.
2. Ejercicios de rango de movimiento: Es supervisado por su limitación por luxación de cadera que genera el riesgo de contracturas si no se realiza adecuadamente.
3. Terapia postural: Es dependiente el cual presenta dificultades como la escoliosis progresiva generando el impacto de empeoramiento de la alineación corporal.

- **Prevención/progresión**

1. Uso de ortesis: Dependiente frente a dificultades como la incomodidad, ajuste constante causando un impacto como la mejora la estabilidad pero puede reducir adherencia.
2. Control del dolor: Dependiente frente a dolor persistente por luxación generando limitaciones frente a todas las actividades funcionales.
3. Posicionamiento adecuado: Dependiente presenta dificultades para mantener una postura prolongada generando el impacto que previene deformidades pero requiere asistencia constante.

4. Barreras y facilitadores

- **Barreras**

1. Físicas: Infraestructura no accesible (escaleras, baños no adaptados), espacios reducidos para silla de ruedas.
2. Clínicas: Progresión de la atrofia muscular Espinal, luxación de cadera, escoliosis.
3. Sociales: Dependencia del cuidador, Limitaciones en integración social.
4. Económicas: Alto costo de terapias, equipos ortopédicos costosos.

- **Facilitadores**

1. Tecnológicos: Silla de rueda eléctrica, ortesis, dispositivos de asistencia.
2. Sociales: Apoyo familiar, inclusión educativa.
3. Sanitarios: Acceso a fisioterapia, tratamiento del dolor.

5. Mapa de dolor

- Dolor mecánico en la cadera por luxación e incrementa con movimiento y transferencias, puede ser crónico.
- Dificultad para realizar actividades básicas, limitación en rehabilitación.
- Ansiedad por progresión de la enfermedad, posible aislamiento social y frustración por dependencia.

6. Expectativas del usuario

- Disminuir el dolor de cadera, mejorar comodidad en sedestación y facilitar actividades básicas en un corto plazo.
- Mantener independencia parcial, mejorar la tolerancia a la rehabilitación y también cómo evitar las complicaciones musculoesqueléticas.
- Mantener calidad de vida como así evitar progresión de deformidades y lograr inclusión social y educativa en un periodo a largo plazo.

Referencia

[1] A. Febrer, M. Vigo, J. Medina y J. Muchart, "Luxación de caderas y dolor en la atrofia muscular espinal tipo III. Casos clínicos," *Rehabilitación*, vol. 51, no. 3, pp. 195–198, 2017.